

Comment monter son projet de Recherche dans le cadre réglementaire actuel ?



&



Pierre AUDOIN – le 5 oct. 2026

Un mot sur moi



FORMATION :

- Master en méthodologie et réglementation de la recherche
- Master en biologie cellulaire
- Bac+6 en médecine
- Langues : Français (maternelle) et Anglais (C1)

EXPERIENCE METIER

- Entreprise individuelle de consulting en recherche biomédicale (2023-actuel, DEEPIA, USENSE, [CERBALLIANCE](#))
- Directeur adjoint de la recherche et de l'innovation de Biogroup (2022-23, restructuration complète du secteur recherche, incluant autorisations pour les 27 sociétés)
- Coordinateur des essais cliniques du laboratoire du CHU Grenoble-Alpes (2015-2021, 7ans et 700 projets)



- Introduction
 - Définitions : EICH, traitement de données.
 - Réfléchir à son projet
 - Catégoriser son projet
- Partie 1 : RNIPH
 - Recherche n'Impliquant pas la Personne Humaine
- Partie 2 : RIPH
 - Recherche Impliquant la Personne Humaine

INTRODUCTION



Définitions

Les EICH



- Echantillons
 - ✗ • EBH : échantillon biologique humain → terme imprécis (Dérivé ? Histologie ?)
 - ✓ • EICH : échantillon issu du corps humain. Introduit les notions de produits, éléments et échantillons du corps humain. Parfaite définition biologique et juridique.
 - ENH : échantillon non humain. En biologie médicale , cela peut être un dérivé modifié ayant perdu son caractère personnel (bactérie, pool de sérum, lignée brevetée)
- Intervention sur la personne humaine et EICH :
 - **Prélèvement** : L'acte invasif de prélèvement n'est pas dénué de risque, de contrainte ou de douleur. Cette action nécessite le consentement du sujet. Il est dit « À risque » (RIPH1) ou « À risque et contrainte minimale » (RIPH2).
 - **Collecte / Recueil** : C'est l'acte de recueil supplémentaire d'un EICH sans acte invasif associé, soit parce que l'acte est en cours pour une autre finalité, soit parce que l'EICH recueilli sort spontanément du patient sans action d'un soignant. Cette action nécessite la non-opposition du sujet (RIPH3).
 - **Reliquats** : Se dit d'un EICH qui est voué à la destruction sans prise en charge pré-analytique ou analytique. **Déchets** (idem sans passage analytique).
 - **Requalification** : Action de modifier la finalité d'un EICH sans recourir à un prélèvement ou une collecte, cette action nécessite l'absence d'opposition du sujet (RNIPH).

Définitions

Les EICH



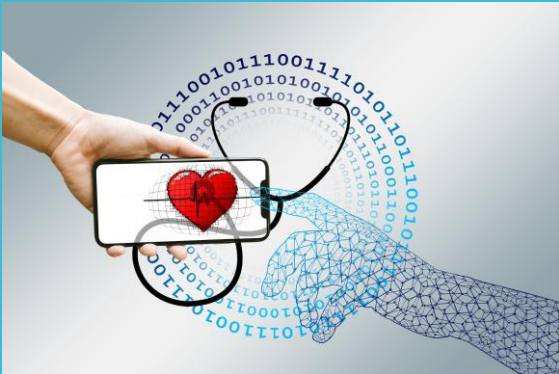
Description d'un EICH

- Intrinsèque :
 - Matrice (sérum, plasma, sang total, urine, selles, ...)
 - Processus de création du dérivé : Pré-analytique standardisé nécessaire ? Délai ?
 - Quantité
- Extrinsèque à l'EICH :
 - Origine (patient, pathologie, ...)
 - Qualification : données cliniques et biologiques associées
- Méthode de conservation :
 - Contenant, délai, sécurité thermique
- La finalité de son prélèvement :
 - le soin, la finalité scientifique (recherche, collection), le judiciaire, le don.
- Son risque :
 - Catégorie B de l'ONU sans risque surajouté (UN3373)
 - Risque de transport : Cat. A de l'ONU (UN2814), présence de carboglace (UN1845).
 - Autre risque : cellule vivante, génétique, ABM (cellule souche, gamète, don d'organe,...), radioactivité,...

	SOIN	RIPH	Déclaration de collection	Autorisation de cession
Etiquetage	Nominatif	Pseudonymisé		
Durée	1 jour à 3 ans (Exception à 20ans : génétique, infectieux et histologie)	15 ans après la fin de la RIPH (ou moins)	20 ans ou moins après la dernière venue du sujet (ou moins : selon la durée maximale de stabilité de l'EICH)	
Information préalable	OUI pour le soin	OUI pour la recherche avec traçabilité au dossier (consentement, non-opposition)		
Liste de correspondance identité	SIL	Fichier d'inclusion - Sécurisé et sur le serveur du RMO	Logiciel dédié collection	
Déclaration	Accréditation COFRAC®	Avis favorable du CPP +/- ANSM selon la typologie	Déclaration au MESR	Autorisation du MESR
Réutilisation	SOIN uniquement Requalification par ré-information du sujet	<u>Recherche :</u> En interne à l'entité juridique Promoteur par amendement au projet. <u>En externe si contrat art R1243-58 du CSP:</u> uniquement transfert collaboratif pour un projet défini	<u>Recherche :</u> RNIPH monocentrique interne à l'entité juridique ayant collecté les EICH. <u>En externe si contrat art R1243-58 du CSP:</u> RNIPH multicentrique= uniquement transfert collaboratif pour un projet défini	<u>Recherche :</u> Par validation du conseil scientifique du CRB <u>En externe si contrat :</u> -Transfert ou cession -Collaboration ou prestation -France/International
Import/Export		+/- Autorisation d'export (UE ou Pays validé par la CNIL possible mais 4 mois)		

Définitions

Le traitement des données



Donnée à caractère personnel (DCP) : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. [Cf partie 2 RNIPH.](#)

Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

Responsable de traitement (RT) : la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec d'autres, est responsable d'une recherche, c'est-à-dire : en assure la gestion, vérifie son financement et détermine les finalités et les moyens des traitements de données nécessaires.

Responsable de la mise en œuvre de la recherche (RMO) : la personne physique désignée par le responsable de traitement, et agissant sous sa responsabilité, veillant à la qualité, l'intégrité et la sécurité des informations et de leur traitement, ainsi qu'au respect de la finalité de celui-ci.

Sous-traitant (ST) : Au sens du RGPD et d'une recherche, personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Il s'agit par exemple du centre participant, d'une société de recherche sous contrat ou d'un prestataire de services informatiques, de centres de ressources biologiques ou d'hébergeurs de données de santé.

Définitions

EICH et données : quel risque ?



•

Un EICH au sens de la RGPD, c'est une donnée en devenir.

Deux risques à encadrer :

- La création d'une donnée ayant un impact médical potentiel.
- La création d'une donnée sensible de catégorie différente : génétique constitutionnelle voire identifiante !

Exemples :

- *découverte d'une positivité sérologique au VIH*
- *mutation de proto-oncogène à pénétrance variable.*

Réfléchir à son projet

Décrire son projet et ses besoins



Initiation du projet au sein de l'équipe recherche

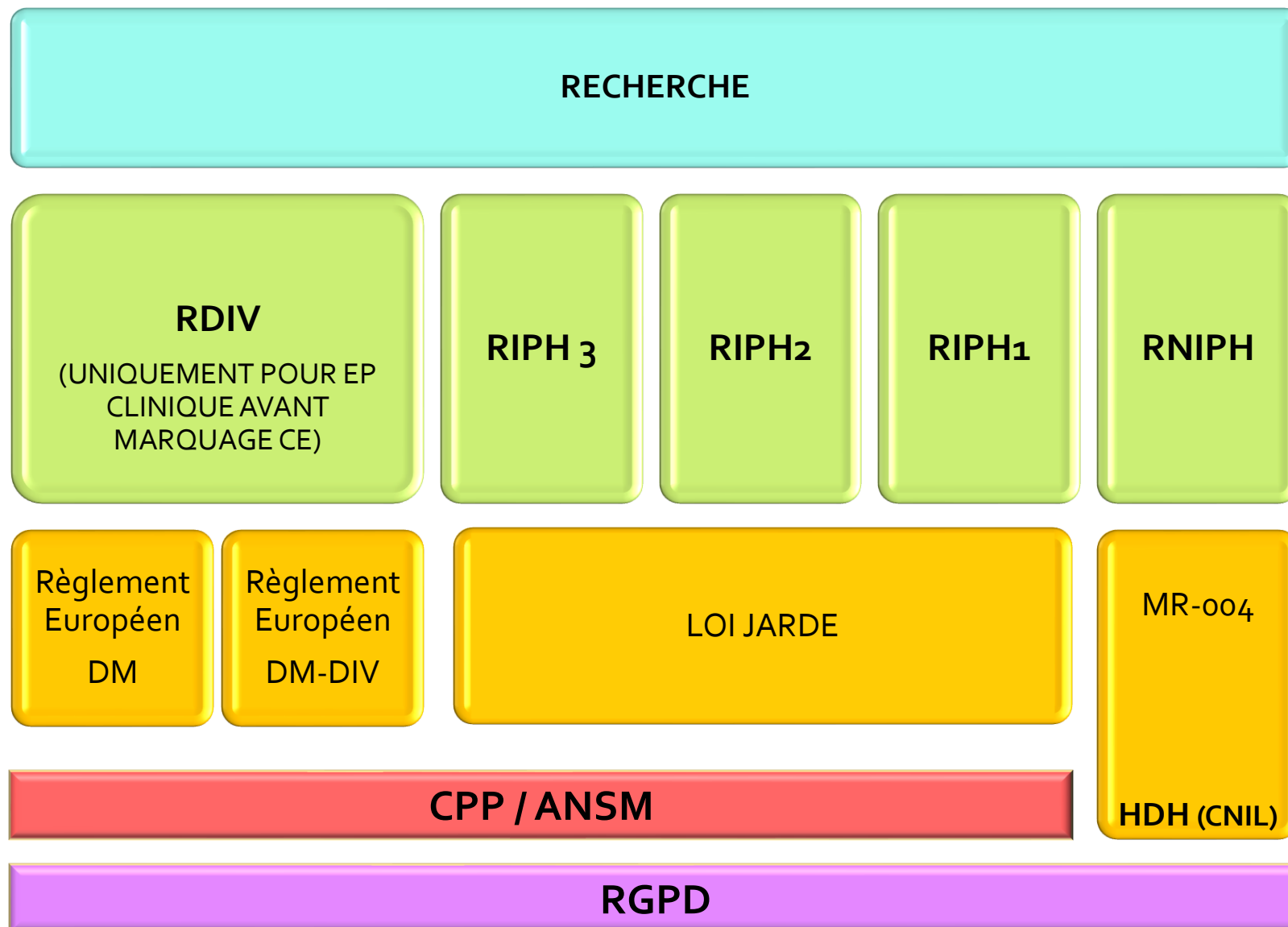
- Idée du chercheur et son équipe
- Bibliographie
- Hypothèse
- Objectif et critère de jugement principal : **PICOT**
 - Population
 - Intervention sur le sujet
 - Comparaison
 - Outcome : critère de jugement mesurable
 - Temporalité de l'étude, des inclusions et du recueil des données.
- Schéma de déroulement (préliminaire) : croisant intervention, besoins et temporalité.

Réunion PRECOCE avec Méthodo + équipe DRCI

- Envisager toutes les problématiques scientifiques ou non : **NSN, faisabilité, intervention sur la personne humaine, juridique, finances, ...**

Catégoriser son projet

Applicabilité des lois de
gauche à droite



Règl EU Médicament

Essais cliniques sur
le Médicament
EU 536/2014
(application 31-01-2022)

Etudes d'efficacité
et/ou de sécurité

Assurance

**Autorisation
autorité EMR et
Avis CPP**

Règl EU DM

Investigations
cliniques pour
sécurité et
performance
EU 2017/745
(application 26/05/2021)

Pour conformité
DM cas 1/2/3
Autres I.C.
cas 4.1/4.2/4.3/4.4

+/- Assurance

Validation coordonnée par ANSM : Avis
CPP +/- autorisation ANSM

Règl EU DM DIV

Etudes
performances
EU 2017/746
(application
26/05/2022)

Pour conformité
DM DIV cas
1/2/3/4

+/- Assurance

Code de la santé publique (CSP) : Loi Jardé Recherche impliquant la personne humaine (RIPH)

Recherches en vue du développement
des connaissances biologiques et médicales
Loi 2012-300 (application 2016)

Type 1
(recherche avec
intervention non
justifiée par le
soin)

Assurance

**Autorisation
ANSM
et Avis CPP**

Consentement
écrit

Type 2
(recherche
interventionnelle
avec risques et
contraintes
minimes)

Assurance

**Avis CPP
puis information à l'ANSM**

Consent^{nt}
écrit ou oral

Type 3

(recherche non
interventionnelle:
aucun risque, ni
contrainte)

Non
opposition

Protocole complet

Protocoles simplifié
ou résumé

Inscription registre DPO par promoteur

MR001 ou MR003
ou autorisa^o CNIL

MR001
ou autorisa^o CNIL

MR001
ou autorisa^o CNIL

MR003 ou MR002
ou autorisa^o CNIL

Déclaration clinicaltrials.gov avant l'inclusion du 1er patient

Autres recherches

- Recherches en santé n'impliquant pas la personne humaine (RNIPH)
- SCAC DM sans procédure additionnelle lourde ou invasive
- Recherches non interventionnelles de médicament

Recherche
interne à
l'équipe de
soin

Recherche multicentrique ou
monocentrique hors équipe de soin

Inscription registre DPO par gestionnaire

Aucune
formalité
CNIL

MR004
Ou si accès
PMSI (MR005
ou MR006)

Si hors MR :
dépôt HDH
(CESREES/CNIL)

+/- comité éthique local
(pour publications)

Information

Information
ou
dérogation

Protocole simplifié

Enregistrement sur répertoire national via HDH

Partie 1 : RNIPH

Recherche N'Impliquant Pas la Personne Humaine

RNIPH

VERIFIER LE CADRE



PROJETS QUI SONT DES RNIPH

Les Recherches N'Impliquant pas la Personne Humaine (RNIPH) font parties des recherches exclues de celles encadrées par la Loi Jardé.

En pratique, elles sont de 2 types :

- Les recherches rétrospectives sur données et/ou sur EICH précédemment collectés.
- Les recherches prospectives qui ne nécessitent aucune intervention et dont la réalisation pourrait s'effectuer en l'absence du sujet dans la pièce. « Si on faisait tout dans un mois ? »

PROJETS QUI NE SONT PAS DES RNIPH

- L'exploitation de données anonymes ou agrégées.
- Les recherches organisées et pratiquées sur des personnes saines ou malades qui ne visent pas :
 - Les champs indiqués au sein de la Loi Jardé pour les RIPH ou au sein du RE pour les RDIV
 - Pour les produits cosmétiques, à évaluer leur capacité à nettoyer, parfumer, modifier l'aspect, protéger, maintenir en bon état le corps humain ou corriger les odeurs corporelles
 - A effectuer des enquêtes de satisfaction du consommateur pour des produits cosmétiques ou alimentaires ou à effectuer toute autre enquête de satisfaction auprès des patients ;
 - A réaliser des expérimentations en sciences sociales
 - A évaluer des modalités d'exercice des professionnels de santé ou des pratiques d'enseignement dans le domaine de la santé.

RNIPH

La MR-004



INTERET

- Méthodologie de référence éditée par la CNIL spécifiquement pour les recherches sur données
- Gain de temps pour le dépôt (enregistrement HDH, délai de 1 mois).
- Respect du RGPD
- Numéro utile pour publier

GRANDS PRINCIPES

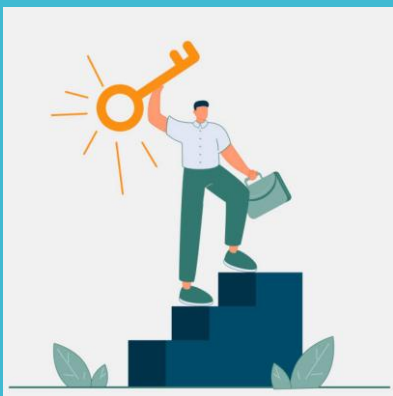
- Données pseudonymisées et non directement identifiante.
- Information individuelle des patients (ou affichage en salle d'attente)
- Traitement limité aux données listées dans la MR
- La liste de correspondance est seulement disponible pour le RMO et son équipe.

LIMITES

Impossibilité de fusionner des bases de données issues de partenaire différents avec chainage de sujets.

RNIPH

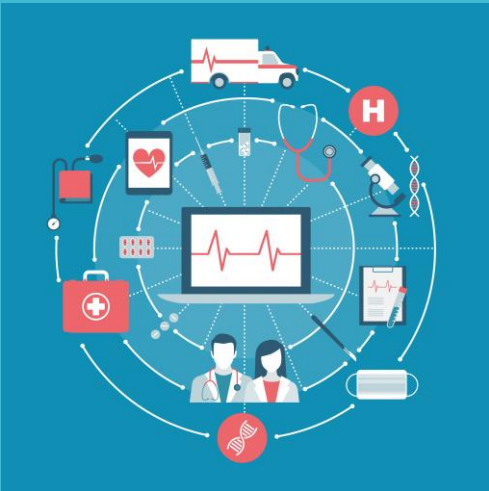
Points clés de la MR-004



- Rôle du RT et RMO (responsable de traitement / responsable de mise en œuvre)
- Nécessité du recours à des données à caractère personnel : intérêt public ou légitime
- Catégorie des personnes concernées : patients (et soignants)
- Information de ces personnes sur l'exercice de leur droit [cf. diapo suivante](#)
- Origine des données : Notion de recueil, d'utilisation et de réutilisation
- Nature : définie au §2,2 de la MR-004 [cf. diapo suivante](#)
- Désidentification : pseudonymisation vs anonymisation (exemple de la DDN)
- Sécurité des données au cours de la mise en œuvre
- Destinataire des données (lieu d'exercice +++)
- Durée de traitement, de la conservation et de l'archivage

RNIPH

Les types de données



Les différentes Natures de Données

- ☐ Données médicales, précisez : _____
- ☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.)
- ☐ Démographie, anthropométrie

Autres catégories de données et si oui, [justifier le besoin en regard des objectifs](#) de l'étude :

- ☐ Etat-civil, identité, données d'identification, images (nom, prénom, adresse, photographie, date et lieu de naissance, etc.)
- ☐ Vie professionnelle (CV, situation professionnelles, scolarité, formation, diplômes, etc.)
- ☐ Données de connexion (adresses IP, logs, identifiants de connexion, horodatage, etc.)
- ☐ Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, ...)
- ☐ Internet (cookies, traceurs, données de navigation, mesures d'audience, ...).
- ☐ Autres ?

Des données sensibles sont-elles traitées ? ☐ OUI ☐ NON

Origine prétendument raciale ou ethnique, opinions politiques ou convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale des personnes, données génétiques et biométriques, données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle, données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions et numéro d'identification national unique (NIR ou n° de sécurité sociale).

RNIPH

Information des sujets



Information initiale

Elle doit être **individuelle**, idéalement **écrite et orale**, généralement uniquement écrite : courrier, compte rendu,...).

Elle doit **expliquer le traitement** des données, sa finalité, ses responsables et leurs partenaires, sa durée, les droits des personnes concernées et notamment les modalités pour s'opposer à ce traitement.

Expl : envoyé dans le CR de biologie médical un texte dont le contenu répond au RGPD.

Information secondaire

Lorsque les conditions d'information initiales sont conformes sur le champ de la finalité poursuivie, les droits des personnes concernées et les modalités d'opposition mais que le projet et ses responsables n'ont pas été clairement définis alors :

La MR-004 prévoit en son article 2.5.1 que le responsable de traitement puisse effectuer une information collective par un dispositif d'information en ligne

Expl : disposer d'un site internet incluant : information complète sur les droits + page dédiée d'information sur les projets + formulaire d'opposition informatisé.

Information unique

Courrier par la poste avec explication du projet et modalités pour s'opposer

**LE DELAI
DE 1 MOIS**

CAS	Désidentification par le responsable de mise en œuvre de chaque centre	Consignes RGPD	Enregistrement par DPO du Resp. de traitement	Déclaration par la <u>DRCI</u>	Information patiente par Responsable de mise en œuvre.	Géré par
RNIPH ne respectant pas la MR-004	Pseudonymisation avec fichier de correspondance	Au maximum selon MR-004 sauf pour le champ de non-application	Analyse d'impact sur la protection des données. Après autorisation CNIL : Enregistrement du traitement de données.	Demande auprès de l'INDS (avis CEREES puis demande d'autorisation à la CNIL)	FIO individuelle <i>(pas de dérogation)</i>	DRCI ET DPO
RNIPH multicentrique		MR-004	Registre commun : Recherches Hors Loi Jardé	HDH	FIO individuelle <i>(postale le plus souvent). (sauf si info préalable et renvoi vers le site internet)</i>	DRCI (Consultation du DPO)
RNIPH monocentrique		Comme une MR-004		Non applicable <i>(HDH si souhait de l'investigateur pour avoir un numéro CNIL).</i>	Affichage en salle d'attente et salle de prélèvement <u>ou</u> FIO individuelle <i>(cf. mention ci supra)</i>	
Recherche sur données anonymisées <i>Exemple : Validation de méthode avec données catégorielles et définitivement anonymisées avant leur traitement.</i>	Anonymisation définitive avant traitement	Pas de MR mais : -catégorisation -anonymisation	Classification -MR-004 -Registre interne -Traitement de données anonymes -Traitement de données agrégées	NON	Absence d'opposition antérieure connue à la recherche ou a réutilisation des données à caractère personnelle	DRCI <u>ou</u> DPO selon la finalité.
Recherche sur données agrégées <i>Exemple : Enquête épidémiologique avec extraction informatique au format de données agrégées</i>	Non applicable car agrégation					DPO

RNIPH

RECAP déroulement



Construction et dépôt

- Définir son projet et son besoin en données / EICH
- **Se rapprocher de son interlocuteur dédié pour les démarches de montage et dépôt réglementaires**
- Ecrire le protocole et ses annexes (information des sujets, base de données) ainsi que contrat(s) et budget si nécessaire.
- Enregistrer au registre interne (DPO) et sur le HDH selon MR-004 (CNIL).
- **Recevoir le mail d'autorisation à démarrer la recherche de la part du RT**

Mise en œuvre

- Commence à la déclaration de 1er inclusion/sélection.
- **Suivre scrupuleusement le protocole : informer les sujets et recueillir les données**
- Déclaration de fin du recueil de données
- Analyses statistiques (suivant le plan d'analyses prévu).

Clôture d'une RNIPH

- Rapport de fin d'essai (maximum 2 ans après la déclaration de fin du recueil de données) et publication
- Archivage (minimum 15 ans et maximum 20 ans)
- **REX +++**

Partie 1 : RIPH

Recherche Impliquant la Personne Humaine

RIPH

BPC = Bonnes Pratiques Cliniques



- Les BPC sont un texte international issues des réflexions post-seconde guerre mondiale et retranscrit dans le droit français la décision du 24 novembre 2006.
- Il s'agit d'un texte qui se veut **pratique et applicable** et définit des termes, des notions et précise le rôle des acteurs d'une RIPH.

Donne un socle réglementaire nécessaire au respect des droits des sujets, de la réglementation sur les essais cliniques et sur les données à caractères personnelles :

- Promotion : encadrement de la recherche
- Investigation : Réalisation de la recherche.
- **Monitoring : contrôle réglementaire et contrôle qualité du CRF versus des données source**
- **Vigilance : EI, EIG dont SUSAR (EIG inattendu), fait nouveau**
- Apportent les compétences permettant de certifier le recueil de données comme fiable pour l'étude.

[Lien vers le texte complet](https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000819256)

<https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000819256>

L'Obtention de la certification BPC est obligatoire tous les 3 ans pour tout investigateur de RIPH (Formation de 4h avec un examen, ne pas y aller sans avoir effectué une lecture préalable)

RIPH

LOI JARDE



La [Loi Jardé](#) (décret en 2017) régit les conduites de recherche sur la personne humaine : *Recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales (ancienne définition des recherches biomédicales)*.

Certaines recherches n'entrent pas dans le champ de la Loi Jardé (RNIPH, RDIV).

Critère de modalité

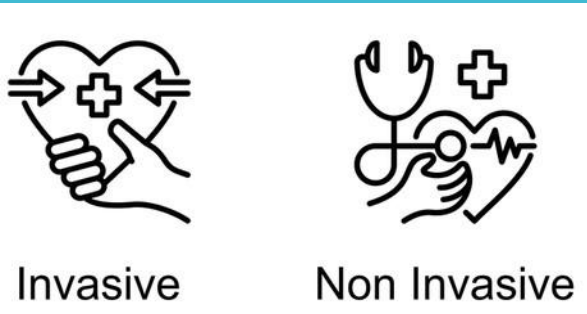
- Organisées et pratiquées sur des personnes volontaires saines ou malades
- Recherche pratiquée sur l'être humain = acte direct sur la personne, nécessite un contact avec la personne
- Implique un acte médical ou paramédical

Critère de finalité

- En vue du développement des connaissances biologiques ou médicales visant à évaluer :
- Mécanisme de fonctionnement de l'organisme humain normal ou pathologique
- Efficacité et sécurité de la réalisation d'actes ou de l'utilisation ou de l'administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d'états pathologiques

RIPH

Typologie de projets



3 catégories de RIPH : approche basée sur le risque pour le sujet

- Recherches interventionnelles = type 1
- Recherches interventionnelles à risques et contraintes minimales = type 2
- Recherches non interventionnelles = type 3 « *interventionnelles dénuées de risque ?* »

3 acteurs nécessaires :

Promoteur

- Responsable de la gestion réglementaire et financière de la recherche

CPP

- Avis favorable du CPP requis
- 1 an d'emprisonnement et 15 k d'amende si RIPH débutée avant avis du CPP

Investigateur

- Médecin en RIPH1
- Extension de la définition pour les recherches de type 2 et 3 = « Personne qualifiée » au regard de l'intervention → Validation CPP

RIPH₁

Interventionnelles



Recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle

Inclus les recherches portant sur :

- Des médicaments
- Ne portant pas sur des produits de santé (par exemple recherches portant sur les actes chirurgicaux)

Catégorisation selon une définition négative : c'est une RIPH qui ne rentre pas dans le décret des RIPH2 et 3.

Information et consentement
écrit du sujet

Autorisation de l'ANSM
Avis favorable d'un CPP (**Délai = 4 à 6 mois**)
Déclaration MR001 (si éligible)

RIPH₂

Interventionnelles, à risques et contraintes minimales



Recherches interventionnelles qui ne comportent que des risques et des contraintes minimales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé + avis du DG de l'ANSM

Elles peuvent comporter l'utilisation de :

- Produits de santé, dans les conditions habituelles
- D'actes peu invasifs (prélèvement veineux sanguins, imagerie sans injection)

Arrêté fixant la liste des recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique

- Patients ou volontaires sains
- Comportant risques et contraintes minimales au regard :
 - de l'âge
 - de la condition physique et de la pathologie éventuelle
 - de la fréquence, de la durée et des éventuelles combinaisons de ces interventions

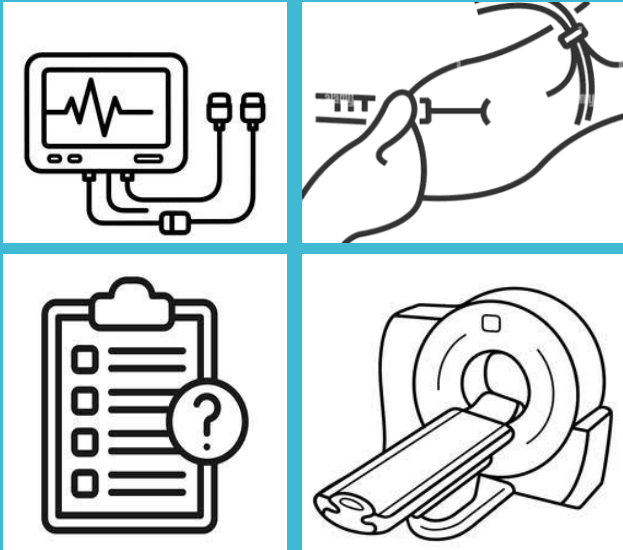
Sont exclues : recherches dont l'objet porte sur un médicament à usage humain

Information et consentement
express écrit du sujet

Avis favorable d'un CPP (**Délai = 4 à 6 mois**)
Transmission à l'ANSM pour information
Déclaration MR001 (si éligible)

RIPH₂

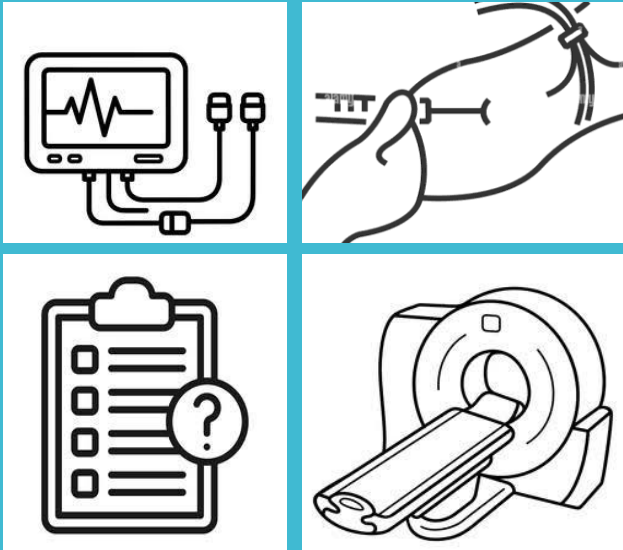
Liste des actes RIPH₂ (annexe de l'arrêté - 1/2)



- ☐ Randomisation entre 2 stratégies / interventions autorisé en pratique courante.
- ☐ Prélèvements sanguins veineux périphérique ou capillaire dont le volume total ne dépasse pas 1mL/kg/j ou 3mL/kg/mois.
- ☐ Autres prélèvements autorisés en RIPH₂ (biopsies cutanées superficielles hors face et des plis, tissus ou biopsies élargis lors d'une chirurgie programmée pour le soin / urines après sondage / écouvillonnage du col utérin, du vagin, de l'œil et du nasopharynx, expectoration provoquée / liquide amniotique ou LCR en + lors d'un prélèvement de soin dont le volume soin + recherche $\leq 5\text{ml}$).
- ☐ Techniques de collecte de données au moyen de capteurs ou de méthodes d'imagerie sans franchissement de la barrière cutanée ou muqueuse et sont réalisées conformément aux recommandations et marquage CE (capteurs intracorporels déjà implanté ou explorations fonctionnelles respiratoires, vidéoscopie ou imagerie ne comportant pas d'injection de produits de contraste ou de médicaments radiopharmaceutiques, par notamment radiographie standard, scanners, IRM).

RIPH₂

Liste des actes RIPH₂ (annexe de l'arrêté - 2/2)



☐ Stimulations externes mécanique/électrique/magnétique réalisées conformément aux recommandations/marquage CE.

☐ Techniques de psychothérapie et de thérapies cognitivo-comportementales dans le cadre d'un protocole établi et validé par un professionnel disposant des compétences appropriées.

☐ Autres interventions susceptibles d'être réalisées dans le cadre de RIPH sur les produits cosmétiques (méthode de stripping, prélèvements de cheveux sans conséquence esthétique significative, tests par instillation dans l'œil, tests d'usage avec prélèvement superficiel, tests de détection de la sensibilité cutanée au moyen de substances pharmacologiques habituellement utilisées pour cet usage, tests de protection solaire avec exposition UV < 3 doses érythémales).

☐ Entretiens, observations et questionnaires dont les résultats peuvent modifier la PEC du sujet.

Expl : Questionnaire risque suicidaire

RIPH₃

Interventionnelles « dénuées de risque »



Recherches qui ne comportent aucun risque ni contrainte dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle

Pas de randomisation possible

Arrêté fixant la liste des recherches mentionnées au 3° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique

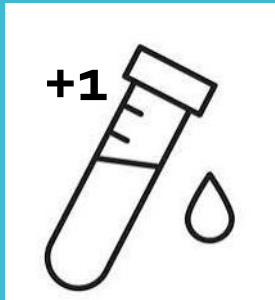
- Personnes saines ou malades
- Comportant actes ou procédures dénués de risques + actes ou procédures sont décrits et justifiés dans le protocole
- Ces recherches réalisées dans le cadre du **soin** et les actes ou procédures ne doivent pas **retarder, prolonger ou perturber le soin**.
- L'absence de risque s'apprécie au regard
 - du sexe, de l'âge,
 - de la condition physique et de la pathologie éventuelle,
 - des risques connus prévisibles des actes ou procédures et de la fréquence, de la durée et des éventuelles combinaisons de ces interventions

Information
et droit d'opposition

Avis favorable d'un CPP (Délai = 4 à 6 mois)
Transmission à l'ANSM pour information
Déclaration MR003 (si éligible)

RIPH₃

Liste des actes RIPH₃ (annexe de l'arrêté)



- ☐ Au décours d'une prise de sang de soin : collecte de volume supplémentaire qui ne dépasse pas 1mL/kg/j ou 3mL/kg/mois ou volume supplémentaire minime de tout épanchement.
- ☐ Recueil d'éléments de produits du corps humain qui ne présente aucun caractère invasif et qui ne sont pas prélevés dans le cadre du soin : salive, glaire, urine, selles, sperme, méconium, lait maternel, colostrum, poils, cheveux, ongle, sueur et écouvillonnage (superficiel de la peau, nez, conduit auditif, cavité buccale et oropharynx, orifice anal et stomies).
- ☐ Recueil de données : Mesures anthropométriques non invasive / Electrophysiologie issue de matériel implanté pour le soin / Enregistrements audio, vidéo, photographiques hors imagerie médicale./ Recueil par capteurs extra-corporels et réalisées conformément aux recommandations et marquage CE (dont mesures électro-magnétiques ou optiques tel que tensiométrie, ECG, EEG, EMG, polysomnographie, spectroscopie dont proche infra-rouge (NIRS), électro-oculographie, , mesures transcutanées dont oxymétrie, capteurs de force, de mouvement ou d'amplitude articulaire, impédancemétrie, calorimétrie indirecte) / échographie externe, doppler, débitmètre.
- ☐ Entretiens, observations, tests et questionnaires qui ne peuvent mettre en jeu la sécurité de la personne ou conduire à la modification de sa prise en charge habituelle et dont les contraintes et inconvénients apportés à la personne qui se prête à la recherche sont négligeables.

RIPH

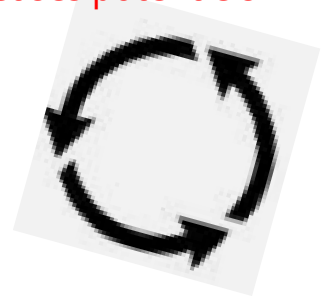
Construction du projet



Construction et dépôts :

1/ A l'issue de la réunion initiale : passer du temps à envisager le projet et ses potentiels problèmes sous tous les angles !

- Les 4 circuits (patient, échantillons, produits de santé, données)
- Le rôle des acteurs, leur mission, leur apport et gain au projet.
- Le montage budgétaire (qui sera actualisé lors des étapes suivantes).



2/ Quand tout a l'air clair : Rédaction

- Écriture du protocole et des documents associées (LINO/LICE, (e)CRF, manuel de plateau technique) selon les modèles fournis.
- Relecture finale : un processus actif.
- Déclaration des investigateurs (CV et Bonnes Pratiques Clinique)

3/ Réunion de fin de construction et dépôts réglementaires

- Finaliser la logistique et autre action (assurance, compte de transport, commande,...).
- Contrat si multicentrique

4/ Réunion de MEP (mise en place)

RIPH

4 erreurs qui font échouer un projet

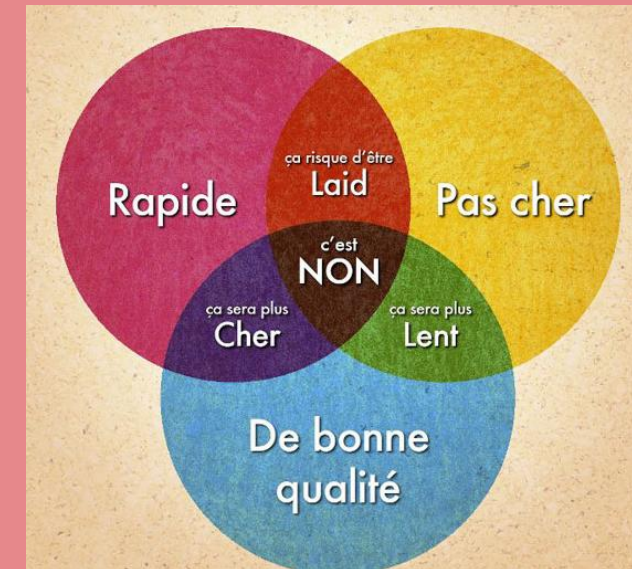


Allez voir les aidants trop tard :
Méthodologistes, CDP et DRCI

Sous-estimer ses besoins :
financiers, matériels, temps, RH,
collaborations (rôle, mission,
attente des parties).

Mal estimer sa population
(mauvaise identification des CI/CNI,
surestimer sa capacité d'inclusion
en confondant file active et
inclusion).

DEMANDER L'IMPOSSIBLE



RIPH

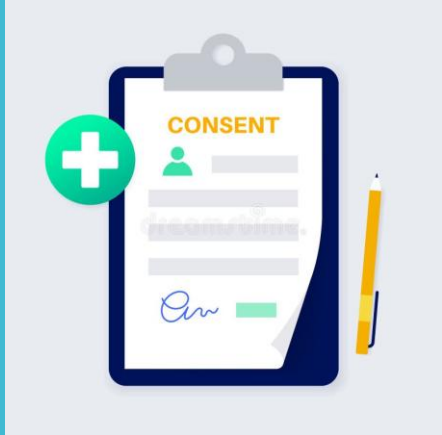
INVESTIGATION



- La réunion de mise en place signe le début de l'investigation avec le **mail d'autorisation à démarrer la recherche**.
- **Investigation**
 - Commence à la déclaration de 1^{er} inclusion/sélection.
 - **Suivre le protocole scrupuleusement : information et consentement, intervention, recueil de données, temporalité.**
 - **Monitoring, vigilance et suivi par l'ARC promoteur.**
 - MS : modification substantielle (autorisation ANSM et avis favorable du CPP préalablement à toutes modifications du projet et notamment des CI/CNI, des visites, des actes à effectuer ou des documents d'information des sujets).
 - Se finit par la déclaration de dernier suivi de dernier sujet
- **Analyses statistiques** (suivant le plan d'analyses prévu).
- **Rapport de fin d'essai** (1 an après la déclaration de dernier suivi), suivi de la **publication**
- **Archivage selon MR** (15 à 25ans, voire 40ans en pédiatrie)

RIPH 1 et 2

Consentement des sujets



Document support validé par le CPP

- Ne pas se tromper de version !

Information

- Claire, loyale et intelligible : niveau de langage +++
- Donnée par un investigateur du projet = diplômé + formé au projet + listé à la délégation des tâches
- Question au sujet : « Pouvez vous me dire ce que vous avez compris de cette recherche ? ». Sa réponse doit intégrer à minima : intervention(s) et durée.

Consentement

- Libre, éclairée, écrit et réversible
- C'est comme au théâtre : Unité de personnes, de temps, de lieu et d'action
= Le patient et le médecin, le même jour, la même pièce avec le même document
- Stylo bleu
- Notion de e-consent.

Risques :

3 ans d'emprisonnement et 45k d'amende si RIPH sans consentement

Merci pour votre attention Avez-vous des questions ?

Prestation possible :

Start-Up

Université

LBM

Entreprise Pharma



CHU **X**

Contact

 06 68 08 22 41

 pierreaudoin@hotmail.fr

 1er RDV le matin (9h-13h)



CONSULTANT EN RECHERCHE CLINIQUE

MES COMPETENCES

Montage de projets (Aide rédactionnelle, méthodologique et statistique).

Biologie médicale (circuit d'analyse, rédaction du manuel)

Dépôts réglementaires (dont RNIPH à la CNIL, Biobanque au MESR)

Ouverture de centre en France (dont Sélection de centre, gestion du Contrat unique)

Accompagnement de start-up DMDIV (dont ISO 13485:2016).